

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

INVENTARIO DE COMPORTAMIENTO INFANTIL (CBCL / 6-18)

Child Behavior Checklist (Achenbach & Rescorla, 2001) · Sistema ASEBA · Adaptación y Baremos Españoles

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y FICHA RESUMEN

Nombre oficial	Inventario de Comportamiento Infantil para Padres (Child Behavior Checklist for Ages 6-18, CBCL/6-18)
Sigla / Acrónimo	CBCL (núcleo del sistema ASEBA: Achenbach System of Empirically Based Assessment)
Autoría original	Thomas M. Achenbach & Leslie A. Rescorla (University of Vermont, 1991, 2001)
Adaptación en español	Sargent, Achenbach et al. (2000); Unidad de Epidemiología Psiquiátrica Univ. Autónoma de Barcelona
Constructo evaluado	Problemas emocionales y conductuales externalizantes e internalizantes y competencias psicosociales
Población diana	Niños y adolescentes de 6 a 18 años (cumplimentado por padres o cuidadores principales)
Tiempo de aplicación	15 a 20 minutos (autoadministrado por los progenitores)
Estructura y formato	113 ítems de problemas de conducta (0 = No es verdad; 1 = A veces; 2 = Muy a menudo) más 20 ítems de competencia
Condiciones de uso	Instrumento psicométrico comercial registrado; distribución oficial por ASEBA (Univ. of Vermont)

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

El CBCL es el pilar empírico fundamental de la psicopatología infantil y del desarrollo moderna. A diferencia de las clasificaciones nosológicas tradicionales basadas en acuerdos de comités de expertos, Thomas Achenbach desarrolló el sistema ASEBA siguiendo un enfoque inductivo y derivado empíricamente (**bottom-up**), mediante análisis factoriales a gran escala de miles de descripciones conductuales observadas por padres, profesores y los propios menores.

El modelo teórico de Achenbach organiza los problemas infantiles en dos grandes espectros psicopatológicos de segundo orden: los problemas **Internalizantes** (malestar autodirigido: ansiedad, retraimiento, quejas somáticas y depresión) y los problemas **Externalizantes** (conflictos heterodirigidos hacia el entorno: agresividad, conducta desafiante y rotura de normas). Paralelamente, el sistema proporciona escalas de cribado orientadas directamente a las categorías del DSM (depresión, ansiedad, TDAH, negativismo y conducta).

3. ESCALAS DE SÍNDROMES DE BANDA ESTRECHA Y AMPLIA

Macroespectro	Síndromes	Rango T	Contenido Psicopatológico Evaluado
Problemas Internalizantes	3 subescalas	T: 30 - 100	1) Ansiedad / Depresión; 2) Aislamiento / Retraimiento / Depresión; y 3) Quejas Somáticas sin base orgánica
Problemas Externalizantes	2 subescalas	T: 30 - 100	1) Conducta de Romper Reglas (desobediencia, robos, fugas); y 2) Conducta Agresiva (peleas, rabietas, crueldad)
Problemas Mixtos / Otros	3 subescalas	T: 30 - 100	Problemas Sociales (rechazo por iguales), Problemas de Pensamiento (obsesiones, tics) y Problemas de Atención
Escalas Orientadas a DSM	6 escalas	T: 30 - 100	Trastornos Depresivos, Trastornos de Ansiedad, Somáticos, TDAH, Negativista Desafiante y Trastorno de Conducta

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, BAREMACIÓN Y CÓMPUTO CLÍNICO

4. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN MULTICULTURAL

Consistencia interna	Excelente consistencia; alfa de Cronbach de la escala Total de Problemas $\alpha = 0.94 - 0.97$; escalas de banda ancha Internalizante $\alpha = 0.90$ y Externalizante $\alpha = 0.92$.
Estabilidad temporal	Fiabilidad test-retest a 1-2 semanas: coeficientes de correlación intraclase CCI = $0.88 - 0.92$, demostrando alta estabilidad temporal.
Concordancia entre padres	Acuerdo inter-informante (madre vs. padre) con coeficientes de correlación de Pearson $r = 0.65 - 0.76$, superior al estándar de la literatura.
Validez de criterio	Distingue con alta sensibilidad ($> 85\%$) y especificidad ($> 88\%$) entre población infantil comunitaria sana y niños derivados a servicios de salud mental.
Estructura multicultural	Validez transcultural demostrada en más de 80 sociedades; España cuenta con baremos específicos agrupados en la Sociedad del Grupo 2 de ASEBA.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

Escala de puntuación	Cada ítem de problemas se puntúa: 0 = No es verdad (en absoluto) ; 1 = A veces o en cierto grado ; 2 = Muy a menudo o casi siempre .
Marco temporal evaluado	Los progenitores valoran el comportamiento de su hijo/a durante los últimos 6 meses .
Transformación a puntuación T	Las puntuaciones directas brutas se convierten obligatoriamente a Puntuaciones T normalizadas (Media = 50, DT = 10) según la edad (6-11 vs. 12-18 años) y el sexo del menor.
Triangulación de informantes	El perfil CBCL se complementa idealmente con el informe escolar de profesores (TRF) y el autoinforme del adolescente (YSR).

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Escalas de Banda Ancha	Subescalas Síndromes	Clasificación	Significación Clínica y Diagnóstica
T < 60 (< Pc 84)	T < 65 (< Pc 93)	Rango Normal	Comportamiento dentro de los límites evolutivos habituales.
T: 60 - 63 (Pc 85-90)	T: 65 - 69 (Pc 93-97)	Rango Límite (Borderline)	Zona de riesgo; alerta evolutiva; requiere monitorización activa.
T $\geq$ 64 ($\geq$ Pc 90)	T $\geq$ 70 ($\geq$ Pc 98)	Rango Clínico Significativo	Patología manifiesta; justificada la intervención psiquiátrica o psicológica.

PUNTOS DE CORTE OFICIALES DE ASEBA:

- **Escalas Totales, Internalizante y Externalizante:** Puntuación **T $\geq$ 64** define el Rango Clínico patológico.
- **Subescalas de Síndromes Específicos:** Puntuación **T $\geq$ 70** (Percentil 98) define el Rango Clínico específico.
- **Alerta de Desregulación:** Puntuaciones simultáneas **T $\geq$ 65** en Ansiedad/Depresión, Atención y Agresión configuran el fenotipo de **Desregulación del Perfil Achenbach** (alto riesgo de TLP y bipolaridad).

DECISIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO, SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA

7. ALGORITMO DE DECISIÓN EN SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL

Paso 1: Corrección informatizada del CBCL: Obtener perfil de Puntuaciones T normalizadas.

Paso 2: Si Problemas Externalizantes $T \geq 64$:

- Investigar ámbito escolar mediante informe de profesores (TRF) para descartar TDAH comórbido con Trastorno Oposicionista Desafiante (TOD).
- Pautar entrenamiento a padres en pautas de crianza positiva y modificación de conducta (**Parent Management Training**).

Paso 3: Si Problemas Internalizantes $T \geq 64$:

- Explorar quejas somáticas como cefaleas y dolores abdominales recurrentes de origen ansioso; evaluar fobia escolar o acoso escolar (**bullying**).
- Psicoterapia infanto-juvenil cognitivo-conductual centrada en la expresión emocional.

Paso 4: Si Hay Sospecha de Pensamientos Autolesivos (Ítem 18 o 91): Entrevista individual confidencial con el menor de inmediato.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO EN PSIQUIATRÍA INFANTO-JUVENIL

Identificación: Niño de 9 años derivado por el orientador escolar y pediatra por conductas disruptivas en el aula, peleas continuas con compañeros, negativa a hacer tareas y accesos de cólera en casa.

Evaluación CBCL (Padres):

- Total de Problemas: Puntuación Directa = 78 (**T = 72**, Rango Clínico Severo).
- Escala Externalizante: **T = 74** (Rango Clínico); Subescala de Conducta Agresiva: **T = 76** (desafía a adultos, rabietas intensas, amenaza a otros niños).
- Subescala de Problemas de Atención: **T = 71** (no termina lo que empieza, impulsivo, no presta atención).
- Escala Internalizante: **T = 52** (Rango Normal).

Diagnóstico Integrado: Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) subtipo combinado comórbido con Trastorno Negativista Desafiante (TND).

Tratamiento: Intervención multimodal: inicio de metilfenidato de liberación prolongada matutino, entrenamiento para padres en manejo de contingencias y adaptaciones curriculares en el centro escolar.

Reevaluación a los 6 meses: La escala Externalizante se redujo a **T = 59** (Rango Normal adaptativo) y Atención a **T = 61** (Límite), logrando estabilidad en el aula y en el hogar.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Banderas Rojas en Infancia:

- **Violencia y Crueldad hacia Animales:** Puntuaciones elevadas en crueldad infantil exigen descartar maltrato doméstico grave o trastorno de conducta disocial severo.
- **Ideación Autolítica Infantil:** Todo reporte de deseos de morir en niños requiere evaluación psiquiátrica urgente.

Diagnóstico Diferencial:

- **Discrepancia entre Informantes:** Padres y profesores coinciden solo moderadamente ($r \approx 0.30$); la conducta puede ser reactiva a un entorno escolar hostil o problemas familiares.
- **Trastornos del Neurodesarrollo:** Descartar TEA en problemas sociales y de pensamiento.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 7ª ED.)

- Achenbach, T. M., & Rescorla, L. A. (2001). **Manual for the ASEBA School-Age Forms & Profiles**. University of Vermont, Research Center for Children, Youth, & Families.
- Sargent, J., Achenbach, T., et al. (2000). Multicultural assessment of child and adolescent psychopathology with ASEBA. *Actas Españolas de Psiquiatría*, 28(4), 211-218.
- Ivanova, M. Y., Achenbach, T. M., Rescorla, L. A., et al. (2007). Testing the 8-syndrome structure of the Child Behavior Checklist in 30 societies. *Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology*, 36(3), 405-417.
- Albores-Gallo, L., Lara-Muñoz, C., Esperón-Vargas, C., Cárdenas-Godínez, C., Pérez-Soriano, P., & Villanueva-Reyes, J. (2007). Validez y confiabilidad del CBCL/6-18 en población mexicana. *Salud Mental*, 30(5), 22-28.